

A plataforma SMSMais

A camada que integra os sistemas que a secretaria já tem — prontuários, PACS, regulação —, entrega ferramentas de gestão e põe o cidadão no celular. Sem trocar o que já funciona.

PARA

Fundação Municipal
de Saúde de Niterói

ASSUNTO

A plataforma
completa

PADRÕES

FHIR R4 · DICOM
SIGTAP · ICP-Brasil

APRESENTADO POR

Automais
Bernardo Almeida

SMSMais

Plataforma de gestão
da saúde municipal



O que o SMSMais faz

Seis frentes, num sistema só, com um cadastro só de cidadão.



Regulação e fila

- A fila de exames e consultas num lugar só
- Quem pediu, para quem foi, há quanto tempo espera
- Produção de cada operador
- Simulação para planejar a oferta



Agenda

- Vagas oferecidas x vagas ocupadas
- Onde sobra e onde falta, por unidade
- Remarcação avisada ao paciente
- Agenda própria de médico e equipamento



Exames e laudos

- Imagem de qualquer aparelho, guardada num acervo só
- Médico lauda dentro do sistema
- Laudo sai assinado digitalmente
- Paciente recebe no celular



Contato com o cidadão

- App com consultas, exames e resultados
- WhatsApp oficial da secretaria
- Confirmação de consulta antes do dia
- Atendimento humano e automático



Transporte de pacientes

- Tratamentos e quem precisa ir, quando
- Rotas do dia e assentos da viagem
- Frota e motoristas no mapa
- Custo consolidado para faturar



Gestão da secretaria

- Perguntas em português, respondidas com número e gráfico
- Indicadores e metas apurados sozinhos
- Ouvidoria com protocolo, prazo e resposta
- Registro de quem fez o quê

Funciona com o que vocês **já têm**

Nenhum sistema da casa precisa sair para o SMSMais entrar.

REGULAÇÃO

SERNIT · SISREG · SER

As filas dos sistemas de regulação aparecem dentro do SMSMais, com a situação de cada pedido e o histórico de quem mexeu.

PRONTUÁRIOS

Os PEPs da rede

O histórico dos sistemas de prontuário que a rede usa hoje é lido e reunido sob o mesmo cidadão — inclusive os mais antigos.

IMAGEM

PACS e aparelhos

Os acervos de imagem existentes e os aparelhos de qualquer fabricante continuam onde estão e passam a ser vistos num lugar só.

BASES NACIONAIS

CNES · CADSUS · SIGTAP

Unidades, cadastro do cidadão e tabela de procedimentos vêm das bases oficiais, sem redigitação.

COMUNICAÇÃO

WhatsApp oficial

O número oficial da secretaria, homologado, usado para avisar, confirmar e atender.

ASSINATURA

Certificado do médico

O laudo sai assinado com validade jurídica e pode ser conferido por quem receber.

A integração é parte da entrega — não um projeto à parte, nem uma conta à parte.

É o que fazemos há anos, e é o que nos diferencia de um sistema que só funciona se tudo for dele. Sistema sem integração pronta? Também resolvemos — e sem depender de o fornecedor querer ajudar.



PARTE 1

Atender e resolver

O caminho de quem precisa de um exame, de uma consulta ou de um transporte — do pedido até o resultado na mão. É aqui que a fila anda ou para.

Do pedido ao laudo **no celular do paciente**

Um caminho só, do pedido até o resultado na mão de quem esperou.

1

Chega o pedido

Vem da regulação ou é aberto na unidade. Já nasce com paciente, procedimento e unidade que vai executar.

2

O aparelho recebe a lista

Cada equipamento vê os pacientes do dia dele. A técnica não digita nome — escolhe da lista, e o exame já sai vinculado.

3

A imagem fica guardada

Todo exame vai para o mesmo acervo, de qualquer aparelho e de qualquer unidade, e abre no navegador sem instalar nada.

4

O médico lauda

Com a imagem ao lado e modelos prontos por tipo de exame. Assina com o certificado dele, com validade jurídica.

5

O paciente recebe

Laudo e imagens no celular, pelo app ou pelo WhatsApp da secretaria. Sem voltar à unidade só para buscar papel.

QUALQUER APARELHO

Raio-X, ultrassom, mamógrafo, tomógrafo — de qualquer fabricante. Aparelho novo entra no sistema no mesmo dia em que é instalado.

O ACERVO ANTIGO ENTRA

Os exames que já existem nos acervos de hoje são trazidos junto. O histórico do paciente não recomeça do zero.

CADA UNIDADE VÊ O QUE É DELA

O que a unidade pediu e o que ela executou. Nada de uma unidade abrir o exame da outra sem motivo.

De onde vem o pedido

- Do sistema de regulação

importado, sem redigitar

- Da própria unidade

aberto na tela, com permissão

- Chegou duas vezes

reconhecido, não duplica

UM PEDIDO SÓ

Já classificado e vinculado

Paciente, procedimento e unidade executante desde o nascimento. O procedimento diz se é imagem, laboratório, consulta ou método gráfico — e o sistema já sabe o que fazer com cada um.

POR QUE ISSO IMPORTA

A maior parte do trabalho perdido em serviço de imagem está em corrigir vínculo errado depois. Exame que nasce certo chega ao laudo sem retrabalho.

Cada aparelho vê só a lista dele

● ● ● US-02 · Policlínica de Icarai · lista de trabalho de hoje

JC José Carlos Ribeiro · US de abdome total

08h40 · aguardando

LB Luciana Barbosa Nunes · US de tireoide

09h10 · aguardando

AF Antônio Ferreira da Silva · US de vias urinárias

09h40 · feito

SR Sebastião Rocha Martins · US de abdome total

10h20 · aguardando

MG Maria das Graças Souza · US pélvico

11h00 · aguardando

RN Raimunda Nonata Freire · US de mama

11h30 · aguardando

6 pacientes. Nada de outra unidade aparece aqui — nem por engano.

“Eu não digito nome. **Escolho da lista** — e o exame já sai vinculado.”



CADASTRO

Aparelho instalado de manhã aparece na lista de trabalho à tarde.

QUALQUER MARCA

Raio-X, ultrassom, mamógrafo, tomógrafo — o padrão é o mesmo há décadas.

SEM CADASTRO

O envio falha com aviso — não em silêncio, que é o pior dos mundos.

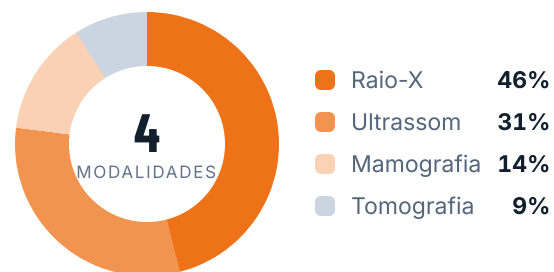
Um acervo, todas as unidades, **todos os aparelhos**

1 acervo

Exames de toda a rede no mesmo lugar, com a mesma busca. O médico vê o de hoje e os anteriores lado a lado, sem abrir outro sistema.

- ✓ Abre **no navegador**, de qualquer computador da rede
- ✓ **O acervo antigo entra junto** — o histórico não recomeça do zero
- ✓ Cada unidade vê o que pediu e o que executou

O que há no acervo, por tipo de exame



Cenário ilustrativo. A composição real é a da rede — e aparece nesta mesma tela.

O QUE O PACIENTE GANHA

Ele deixa de carregar envelope de radiografia entre unidades — e deixa de repetir exame porque o anterior se perdeu.



LAUDO

0 médico lauda **aqui dentro**

Imagem e laudo na mesma tela

Sem trocar de programa e sem baixar nada. Abre no navegador, de qualquer computador da rede.

Modelos por tipo de exame

O texto padrão já vem pronto e editável. O médico escreve o que é daquele caso, não o que se repete em todos.

ASSINADO, NÃO DIGITALIZADO

A assinatura é a do certificado do próprio médico, com validade jurídica — e quem recebe o PDF consegue conferir se é autêntico.

Laudo · Raio-X de tórax

Paciente 0042 · 18/09



TÉCNICA

Radiografia de tórax em incidência **PA**, realizada em ortostase.

ACHADOS

Campos pulmonares **sem opacidades** focais. Seios costofrênicos livres. Área cardíaca de dimensões normais. Estruturas ósseas preservadas.

CONCLUSÃO

Exame sem alterações significativas.



Assinado digitalmente

Certificado ICP-Brasil · verificável pelo paciente

Modelos que o serviço **ajusta sozinho**

LAUDO DO ZERO

O médico digita técnica, achados normais e conclusão em todo exame — **inclusive nos 80% que não têm nada.**

Cada laudo é um documento novo. O que se repete se digita de novo.



COM MODELO

O padrão já vem pronto. O médico escreve só o que é daquele caso.

Raio-X de tórax tem um modelo; mamografia tem outro, com a classificação que o rastreamento exige.

-4 min por laudo

é o que um modelo tira de um exame sem alteração — a maioria deles.

QUEM MANDA

O serviço de imagem

Cria e ajusta os modelos na própria tela. Não depende de pedido a fornecedor.

CABEÇALHO

A marca da secretaria

Cabeçalho e rodapé valem para todos os laudos e mudam num lugar só.

LAUDO MAIS RÁPIDO É FILA MENOR

O gargalo do serviço de imagem raramente é o aparelho — é o tempo até o laudo sair. Minutos por exame viram dias de fila.

0 laudo chega e pode ser conferido



1

Sai assinado

Com o certificado do próprio médico.
Vale como documento.

2

Chega ao paciente

App ou WhatsApp oficial, com aviso na
hora em que fica pronto.

3

Ela abre no celular

Laudo e imagens. Sem voltar à unidade
para buscar papel.

4

Quem recebe confere

Página pública: o PDF é autêntico e não
foi alterado.

5

Se precisar refazer

Versão nova, registrada. A anterior não
some — some a dúvida.

O QUE MUDA NA ROTINA

Some a fila de balcão para retirar resultado — que em muitas unidades é a maior fila do dia e não atende ninguém: só entrega papel.

Quando o exame vai para o paciente errado



DIA 1 · 09H12

A técnica seleciona o item errado da lista

O paciente anterior. As imagens são arquivadas sob a pessoa errada. Acontece em todo serviço de imagem.

DIA 1 · 14H

O laudo é assinado — no prontuário de quem não fez o exame

É o tipo de erro que só aparece meses depois, quando alguém compara com a história clínica.

DIA 9 · A RECEPÇÃO PERCEBE

Uma tela corrige de quem é o estudo

A imagem é reescrita no acervo, os rascunhos de laudo são descartados e o link já enviado ao paciente é revogado.

REGISTRO

Autor, data e motivo ficam gravados

É permissão à parte, dada a um punhado de nomes — não a todo mundo que mexe com exame.

Três sistemas, uma fila só



PREFEITURA DE

niterói

TEMPO DE AVANÇAR

SAÚDE

RM Rita Menezes
rita.menezes@saude.niteroi.rj.gov.br

Regulação

Fila da regulação 284

Nova solicitação

Notificações 7

Estatísticas

Agenda

Exames de imagem

Atendimento

Ouvidoria

Transporte

Inteligência

Sair

Todas as unidades

7

RM Rita Menezes

Fila da regulação ?

+ Nova solicitação

Solicitações de toda a rede, por prioridade e tempo de espera.

Protocolo, nome ou CPF

Todos os procedim...

Prioridade

Todas as unidades

Todos os siste...

Aguardando 284

Em análise 46

Pendência na ponta 31

Agendadas 612

Devolvidas 18

SOLICITAÇÃO	PACIENTE	PROCEDIMENTO	UNIDADE SOLICITANTE	PRIORIDADE	SISTEMA	SITUAÇÃO	ESPERA
2026-018842	Raimunda Nonata Freire	Consulta em cardiologia 0301010072	Policlínica do Centro	Alta	SERNIT	Aguardando	128 dias
2026-018791	José Carlos Ribeiro	US de abdome total 0205020046	UBS Barreto	Normal	SISREG	Aguardando	74 dias
2026-018774	Maria das Graças Souza	Mamografia bilateral 0204030188	Policlínica de Icaraí	Urgente	SISREG	Em análise	6 dias
2026-018760	Antônio Ferreira da Silva	Consulta em oftalmologia 0301010137	UBS Engenhoca	Normal	SERNIT	Pendência	suspense
2026-018742	Luciana Barbosa Nunes	Tomografia de crânio 0206010044	Hospital Municipal	Alta	SER-RJ	Em análise	11 dias
2026-018715	Sebastião Rocha Martins	Consulta em ortopedia 0301010200	Policlínica do Centro	Normal	SERNIT	Aguardando	96 dias

Mostrar 25

284 solicitações

<

1

2

3

>

O caminho de uma solicitação, com a volta desenhada



Todo sistema tem as cinco etapas. O que muda aqui é a **seta tracejada**: devolver, reclassificar e recusar são atos com autor, data e o papel de quem fez — a pergunta “por que este demorou?” tem resposta em vez de silêncio.

Três filas **uma visão**

● **SERNIT**

o sistema da própria casa

● **SISREG**

nacional, com a agenda importada

● **SER**

estadual — o encaminhado não some

O PACIENTE É UM SÓ

A repetição aparece sozinha

Hoje, saber se alguém já foi encaminhado por outro caminho exige abrir três sistemas e comparar na mão. Reunidos, a vaga duplicada aparece — e vaga duplicada é vaga perdida.

O QUE NÃO MUDA

Cada sistema continua sendo operado onde é. A plataforma lê a situação de cada pedido e o histórico de quem mexeu — não substitui nenhum deles.

Onde sobra e onde falta

A vaga que ninguém usou e a fila que não anda costumam estar na mesma semana.

O QUE A AGENDA MOSTRA

Vaga oferecida × vaga ocupada

- Por unidade, por especialidade e por profissional
- Quantas vagas foram abertas e quantas foram usadas
- Onde a fila espera mais tempo pelo mesmo procedimento
- Quanto da agenda do mês já está comprometido

O QUE O SISTEMA FAZ COM ISSO

Avisa e organiza

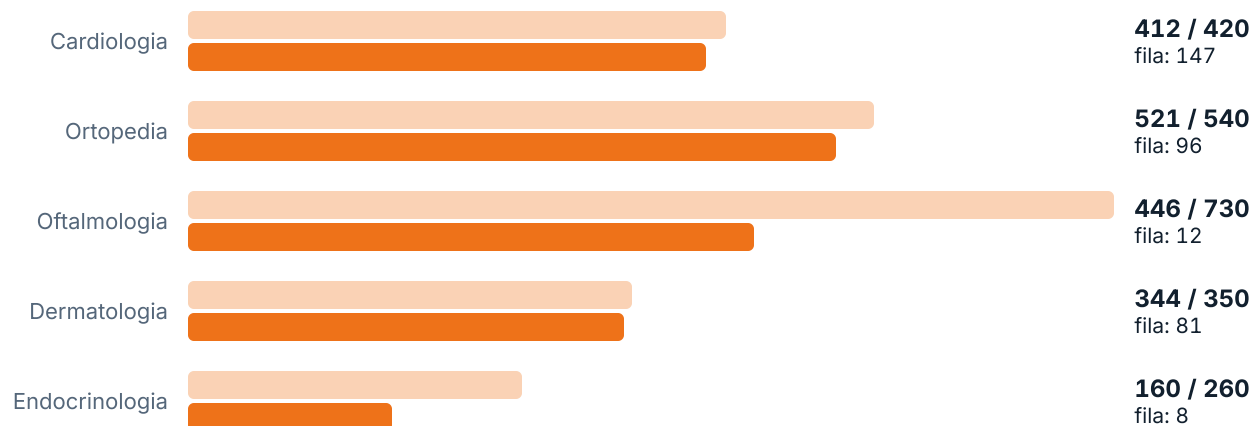
- Remarcação e troca de profissional viram aviso ao paciente
- Vaga que sobrou aparece antes de virar falta
- Agenda própria por médico, sala e equipamento
- Simulação: “se eu abrir mais dois dias, a fila zera quando?”

O gestor deixa de descobrir o problema pelo paciente

Hoje a notícia de que a agenda estourou costuma chegar pela reclamação de quem não conseguiu marcar. Com a oferta e a ocupação lado a lado, ela chega antes — e dá para remanejar enquanto ainda é remanejamento, não crise.

A oferta contra a fila

Vagas abertas x usadas no mês, por especialidade



abertas usadas · números de cenário

LÊ-SE ASSIM

Oftalmologia sobra, cardiologia falta

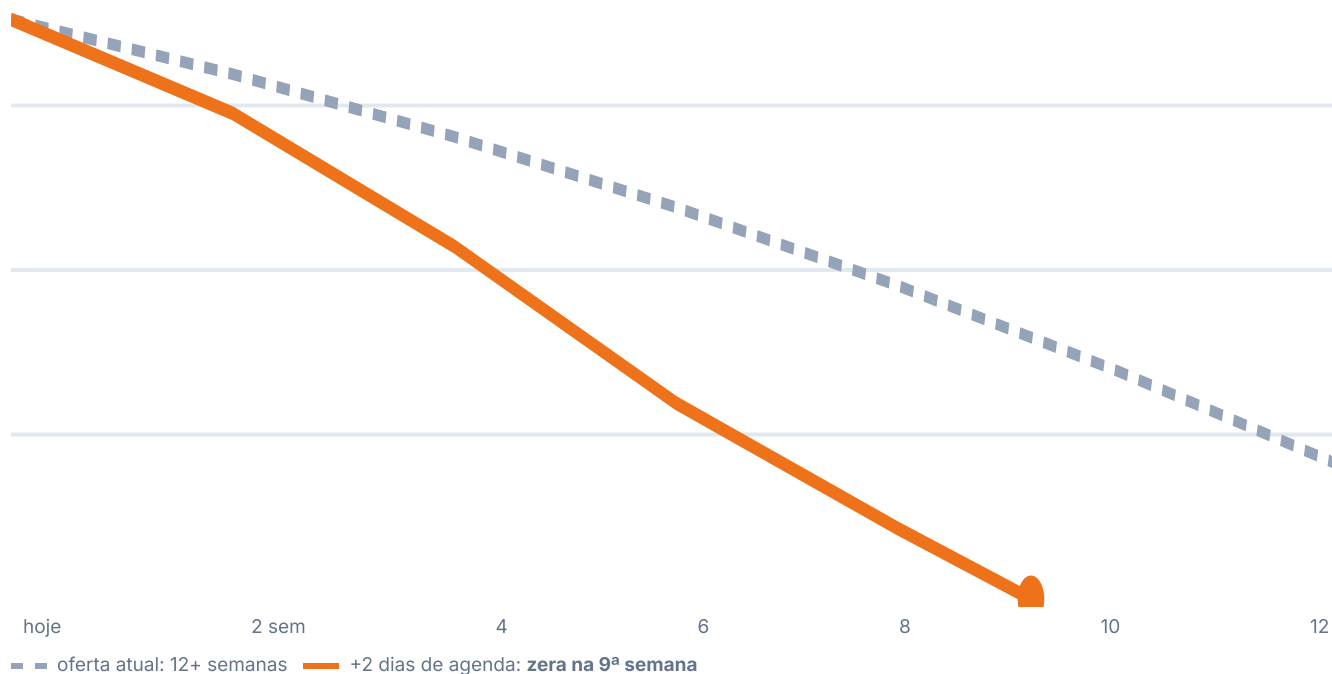
284 vagas de oftalmo venceram vazias no mês; cardiologia usou 98% e ainda tem 147 na fila. Não é mais oferta que resolve — é **remanejar**.

O QUE ISSO DESTRAVA

A notícia de que a agenda estourou deixa de chegar pela reclamação de quem não conseguiu marcar.

“Se eu abrir mais dois dias, a fila zera quando?”

Fila de cardiologia, semanas à frente — dois cenários



9 semanas

em vez de “não sei”. A pergunta que hoje se responde no chute passa a ter conta.

SÓ PLANEJAMENTO

A simulação **não marca nada e não altera agenda nenhuma**. Ela existe para decidir antes de mexer — e a decisão fica guardada com quem tomou.

UMA RESSALVA

A simulação vale pela oferta que se informa. Ela não prevê falta de profissional nem aparelho quebrado — mostra o teto do que a oferta planejada alcança.

Quando a agenda muda **depois de marcada**

"Antes ele descobria **na porta** que o médico não vinha."



POR QUE É MAIS QUE CORTESIA

Paciente que viaja para uma consulta que mudou de dia perde diária, transporte e confiança. O terceiro é o mais caro de recuperar.

A produção de quem opera

AUTORIZADAS NO MÊS

2.140

SISREG + SERNIT + SER

DEVOLVIDAS À PONTA

318

com pendência nomeada

TEMPO MÉDIO NA MÃO

1,8 dia

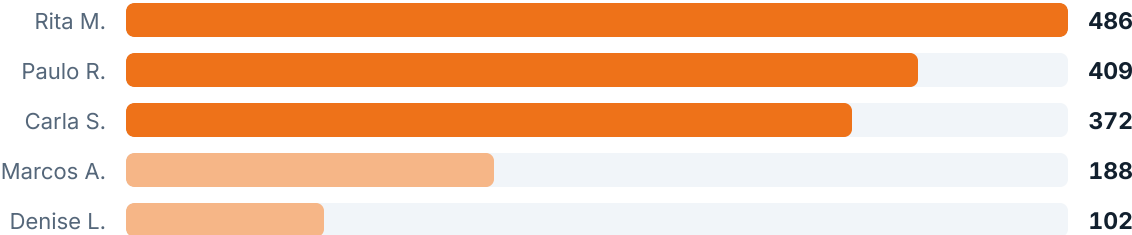
de assumir a decidir

PARADAS > 5 DIAS

41

é aqui que se olha primeiro

Solicitações decididas por operador — SISREG



Denise entrou na equipe há três semanas. A leitura é **onde reforçar**, não quem cobrar.

POR SISTEMA

Equipes diferentes, leituras separadas

Quem cuida do SISREG não é quem cuida do SERNIT. Cada sistema tem a sua tela e a sua permissão.

QUEM ENXERGA

Permissão própria, desligada por padrão. Quem atende não precisa ver o ranking das colegas; quem coordena, precisa.



Quem vai, a que custo

1

Quem precisa ir

O tratamento do paciente diz para onde, com que frequência e até quando. A lista do dia sai sozinha — ninguém monta na mão toda manhã.

2

A rota do dia

Veículo, motorista, assentos e quem senta em cada um. Acompanhante entra na conta. Falta e remarcação ficam registradas.

3

A frota no mapa

Onde cada carro está, por onde passou e se chegou. O paciente

O QUE O PACIENTE SENTE

Ele sabe se o carro vem, a que horas e se o lugar dele está garantido. A avaliação da viagem volta para a secretaria.

4

O custo fechado

Viagem, quilometragem e ocupação consolidados por

O QUE A SECRETARIA GANHA

Assento vazio e rota que não se justifica ficam visíveis. É a parte do orçamento que mais some em planilha.

PARTE 2

Falar com o cidadão

A secretaria já sabe o que o cidadão precisa saber: quando é a consulta, se o exame ficou pronto, se o transporte passa. Falta chegar até ele — no canal que ele já usa.

Ela não precisa **ligar para a unidade**

O que está marcado

Consulta e exame com data, hora e endereço. Se mudar, ela é avisada — não descobre na porta.

O resultado, quando sai

Laudo assinado e imagens no celular, com aviso na hora em que ficam prontos.

Se o carro vem

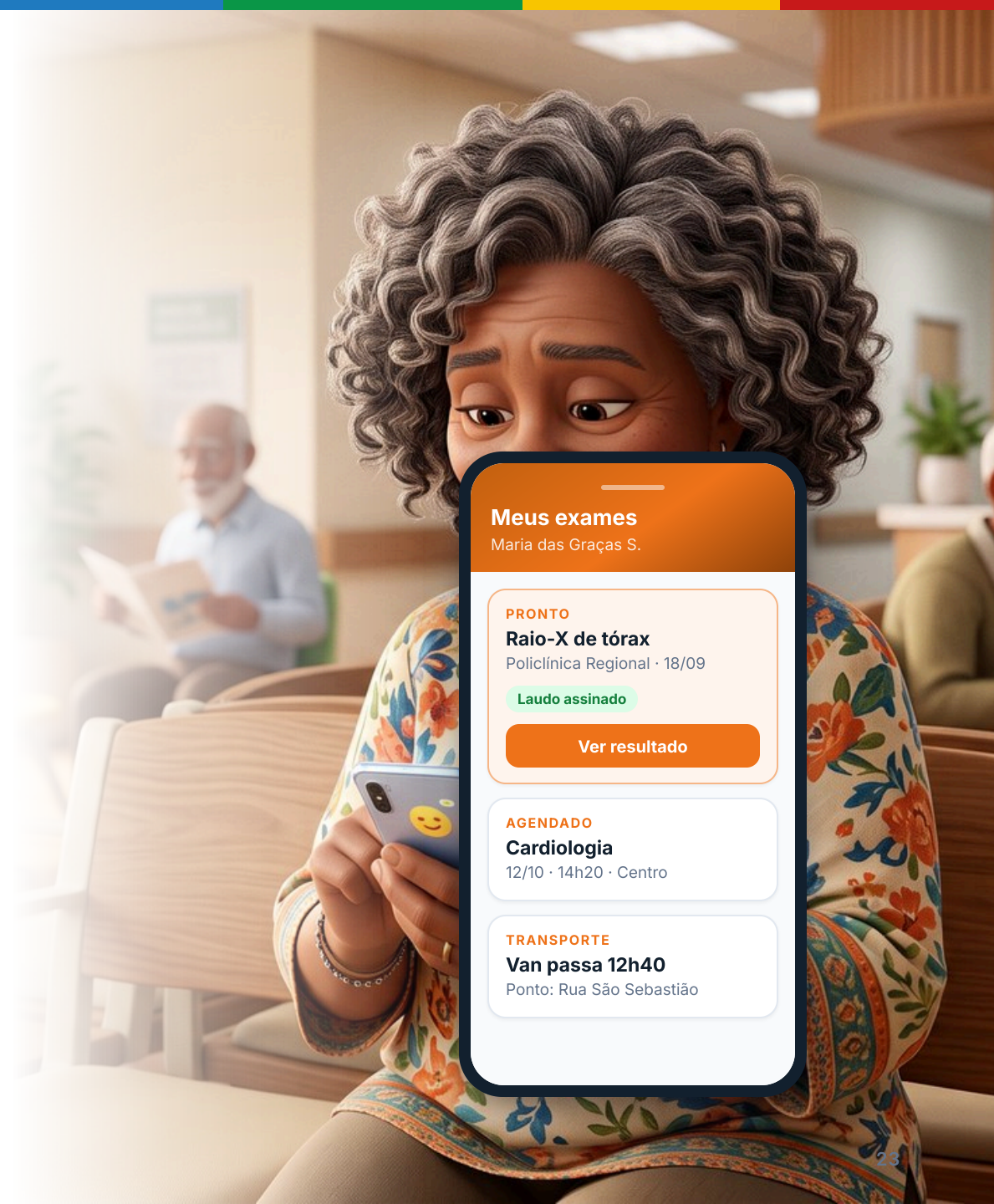
Dia da viagem, horário e acompanhamento do veículo do transporte sanitário.

Falar com a secretaria

Pelo app ou pelo WhatsApp oficial — e quem atende já vê o histórico dela.

Quem não tem o app continua atendido

Tudo o que o app mostra, o WhatsApp oficial também avisa. Instala pelo navegador, sem loja de aplicativos — e ninguém fica de fora por não instalar.





WHATSAPP OFICIAL

A vaga não morre calada

Confirma antes do dia

Quem não vai, avisa. A vaga volta para a fila a tempo de ser usada — em vez de virar falta.

Robô atende, pessoa assume

O automático resolve o simples. Quando a equipe entra na conversa, o robô para de tentar.

NÚMERO CERTO, PESSOA CERTA

Se o telefone não é do paciente, vira pendência para a recepção corrigir — e nada mais sai para aquele número.

Hoje

Olá, Dona Terezinha! Aqui é a Saúde de Niterói. A senhora tem **consulta de cardiologia marcada para 12/10, às 14h20**, na Policlínica do Centro. Consegue comparecer?

09:12 ✓✓

Sim, vou

Não vou poder

Vou sim, obrigada!

09:31

Perfeito. Leve documento com foto e o cartão do SUS. Se precisar do transporte sanitário, responda **TRANSPORTE**.

09:31 ✓✓

De cada 100 agendados, o que acontece

"Chego e já sei para quem eu preciso ligar de verdade."

62
confirmaram

↓
Saem da lista. A equipe trabalha só o que sobrou.

14
não vão

↓
Vaga volta a tempo de remarcar outra pessoa.

16
não responderam

↓
Nova tentativa no ritmo que a secretaria definiu.

8
nº errado

↓
Pendência para a recepção.

30 ligações a menos

para cada 100 agendados: 62 confirmaram e 8 nem tinham número certo. Sobram **30 contatos** que precisam de gente.

14 vagas recuperadas

quem avisou que não vai deixa a vaga livre **antes do dia** — e ela é oferecida a quem está na fila.



Quem atende **sabe com quem fala**

● ● ●

Central de Atendimento · Policlínica do Centro · 11 conversas abertas

TA

Terezinha Alves Pinto · quer saber do transporte

com Luana C. · 2 min

JC

José Carlos Ribeiro · resultado do US saiu?

robô respondeu · 5 min

MG

Maria das Graças Souza · remarcar mamografia

sem dono · 14 min

AF

Antônio Ferreira da Silva · endereço da UBS

resolvida · 22 min

LB

Luciana Barbosa Nunes · transferida de Icaraí

com Rita M. · 31 min

"Sem dono" há 14 minutos é o que a coordenação vê primeiro.

"Abro a conversa e o **histórico dela já está do lado**. Não pergunto de novo."



FILA POR UNIDADE

Cada casa atende a sua — não uma caixa única onde ninguém se responsabiliza.

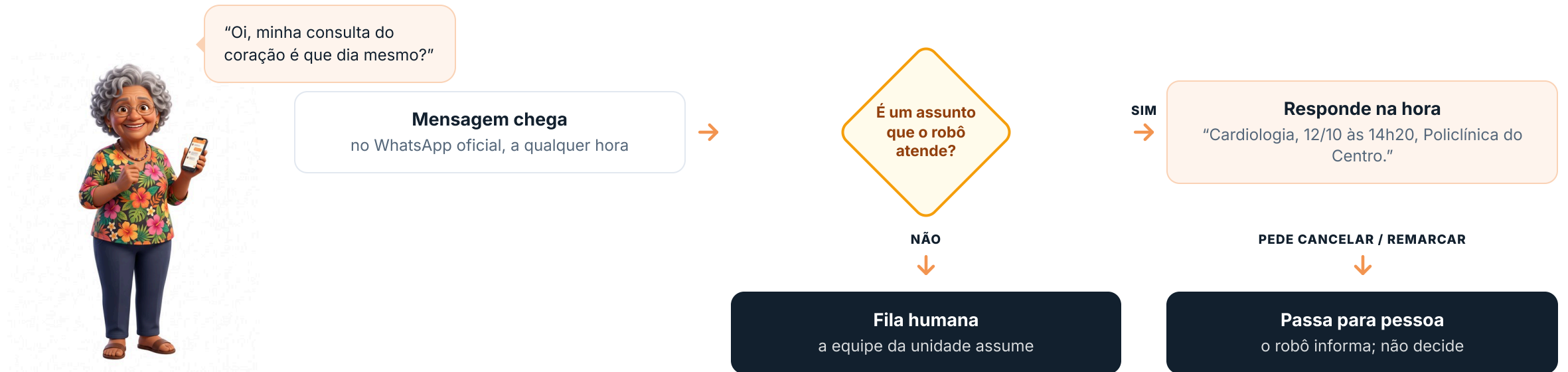
POSSE

A conversa tem dono enquanto está sendo atendida. Ninguém responde por cima.

SUPERVISÃO

Quem coordena vê todas e redistribui o que parou — permissão à parte.

Onde o robô responde e onde ele sai da frente



ESCOPO

A secretaria escolhe a lista de assuntos. Fora dela, ele não tenta.

TREINO

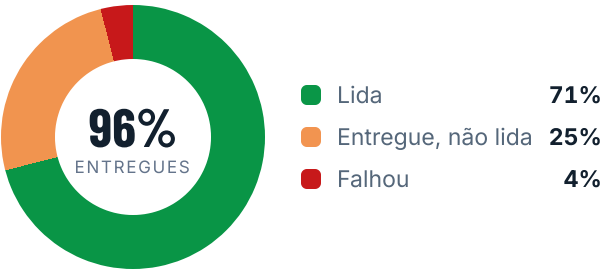
Corrigido pelo atendente a partir de conversas reais — não de manual.

A REGRA

Humano entrou, robô para. Nunca os dois na mesma conversa.

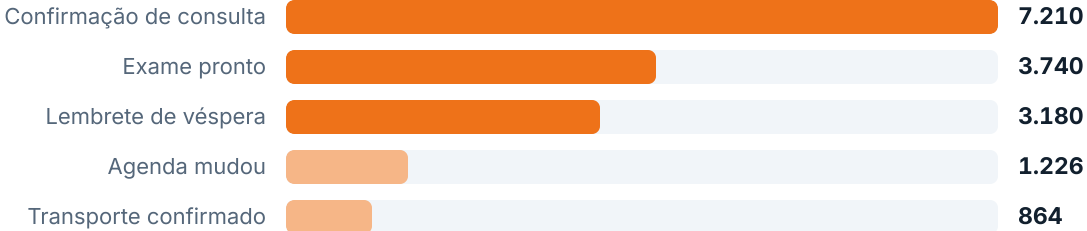
O que saiu, o que chegou, o que falhou

Status de entrega — mês



Dos 4% que falham, quase tudo é número inválido — e cada um vira pendência de cadastro com nome.

Templates mais enviados



Reenviar com o número corrigido não dispara de novo para quem já respondeu.

A avaliação que **vira** indicador



"Deram cinco estrelinhas pra eu apertar. Apertei."

4,6 de 5

média do mês, **1.912 respostas**. Enviada pelo mesmo canal, logo após o atendimento — enquanto a pessoa lembra.

Distribuição das notas



LIGADA A QUÊ

A resposta nasce amarrada à unidade e ao profissional avaliados — vira indicador por unidade e por período, inclusive o de satisfação que a Lei 13.460 exige da ouvidoria. Não é uma nota solta sobre “a saúde do município”.

Cada login é um ramal

A ligação deixa de ser o único atendimento que não fica registrado em lugar nenhum.

Ligar e receber de onde estiver

Quem entra no sistema fica com o ramal ativo — no aparelho da mesa ou no próprio navegador.

A ligação já chega com nome

O número identifica o paciente e o cadastro abre junto com a chamada — sem perguntar o que a secretaria já sabe.

VOZ E TEXTO NO CADASTRO

Gravada e transcrita no histórico, ao lado das conversas de WhatsApp. Dá para procurar **pelo que foi dito**.



Terezinha Alves Pinto

Histórico de contatos · 3 chamadas, 8 mensagens



Recebida · 21/09, 09h12 · 2min 41s

Ramal 2041 · Luana C.



0:58 / 2:41

Terezinha: Moça, é sobre a consulta do coração, dia doze...

Atendente: Cardiologia, dia 12/10 às 14h20, na Policlínica do Centro. A senhora confirmou pelo WhatsApp semana passada.

Terezinha: Isso. Só queria saber da condução.



Feita · 14/09, 15h04 · 1min 12s

Ramal 2038 · Rita M.



Recebida · 02/09, 10h33 · 3min 05s

Ramal 2041 · Luana C.



WhatsApp · 15/09, 09h12 · confirmou a consulta

Automático

• No roteiro

A telefonia IP das unidades, a central e a gestão de ramais **já operam hoje** — 31 unidades ligadas, com cada aparelho identificado pela própria unidade. O que entra no roteiro é o ramal amarrado ao login e a gravação com transcrição dentro do cadastro do paciente.

O módulo que vocês já conhecem, **no lugar dele**

Apresentado na reunião anterior. Aqui só o resumo, e onde ele se encaixa no resto.

Entra por qualquer porta

Balcão, telefone, WhatsApp, e-mail, site, app, Disque 136, Fala.BR — um registro só, e todo mundo sai com protocolo.

Vai a quem resolve

A policlínica, o hospital, a regulação, a farmácia. Cada área tem responsável e prazo próprio.

O relógio corre sozinho

Os prazos da lei são contados, cobrados e escalonados pelo sistema. Nada vence no silêncio.

Vira relatório

O relatório anual e a pesquisa de satisfação que a Lei 13.460 exige saem da própria base, prontos.

A DIFERENÇA DE ESTAR JUNTO

A reclamação sobre a fila de cardiologia já chega ligada ao pedido de regulação real daquele cidadão. A ouvidoria não responde “encaminhamos ao setor” — ela vê o pedido, a data e a situação, e responde o que aconteceu de verdade.

Metade das queixas de uma secretaria de saúde é sobre espera. Sem essa ligação, a ouvidoria vira caixa de protocolo.

DENÚNCIA

Trilho separado

Sigilo e anonimato conforme a lei, com registro de cada acesso à identidade e teor sem identificação para quem apura.

O que a lei cobra, no lugar dele



1

Entra por qualquer porta

Balcão, telefone, WhatsApp, site, app, Fala.BR. Sai com protocolo.

2

É triada

Seis tipos oficiais, assunto do OuvidorSUS, prioridade. Denúncia corre em trilha próprio.

3

Vai a quem resolve

A policlínica, o hospital, a regulação, a farmácia — com responsável e prazo.

4

O relógio cobra

30 dias ao cidadão, prazo menor à área. Cobrança e escalonamento automáticos.

5

Vira relatório

O anual e a pesquisa de satisfação que a Lei 13.460 exige saem da base.

A DIFERENÇA DE ESTAR JUNTO

A reclamação sobre a fila de cardiologia chega ligada ao pedido de regulação real daquele cidadão. A ouvidoria responde o que aconteceu — não “encaminhamos ao setor”.

PARTE 3

Enxergar a secretaria

Cada sistema dá o seu pedaço, e o gestor soma planilha. Aqui o número sai da própria base, na hora, por unidade e por período.

Pergunte em português

Sem relatório para pedir, sem planilha para esperar, sem saber onde o dado mora.

Quem pergunta é o gestor

Não é um relatório pronto que alguém programou meses atrás. É a pergunta de hoje, feita com as palavras de quem precisa decidir.

A resposta vem com a conta à vista

Número, tabela ou gráfico — e o caminho que o sistema percorreu para chegar ali, se alguém quiser conferir.

O QUE ELA ALCANÇA

A fila, a agenda, os exames, o transporte e as conversas com o cidadão. Cada base é liberada por permissão — quem não pode ver, não pergunta.

Consulta inteligente

Base: Regulação

Quantas pessoas esperam mais de 90 dias por cardiologia, e em quais unidades?

consultando a fila...

Hoje há **412 solicitações de cardiologia** na fila. Dessas, **147 esperam mais de 90 dias** — concentradas em quatro unidades:

147 pessoas
ACIMA DE 90 DIAS

Espera acima de 90 dias, por unidade solicitante



A espera média desse grupo é de **127 dias**. A Policlínica do Centro sozinha responde por **39%** do total.

A meta apurada **sozinha**

O número que hoje alguém monta em planilha no fim do mês sai da base, no dia em que se pedir.

ATENDIMENTO NO PRAZO

92,4 %

meta ≥ 90% · **acima**

TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA

9,1 dias

meta < 10 · **acima**

ESTOQUE EM ABERTO

14 %

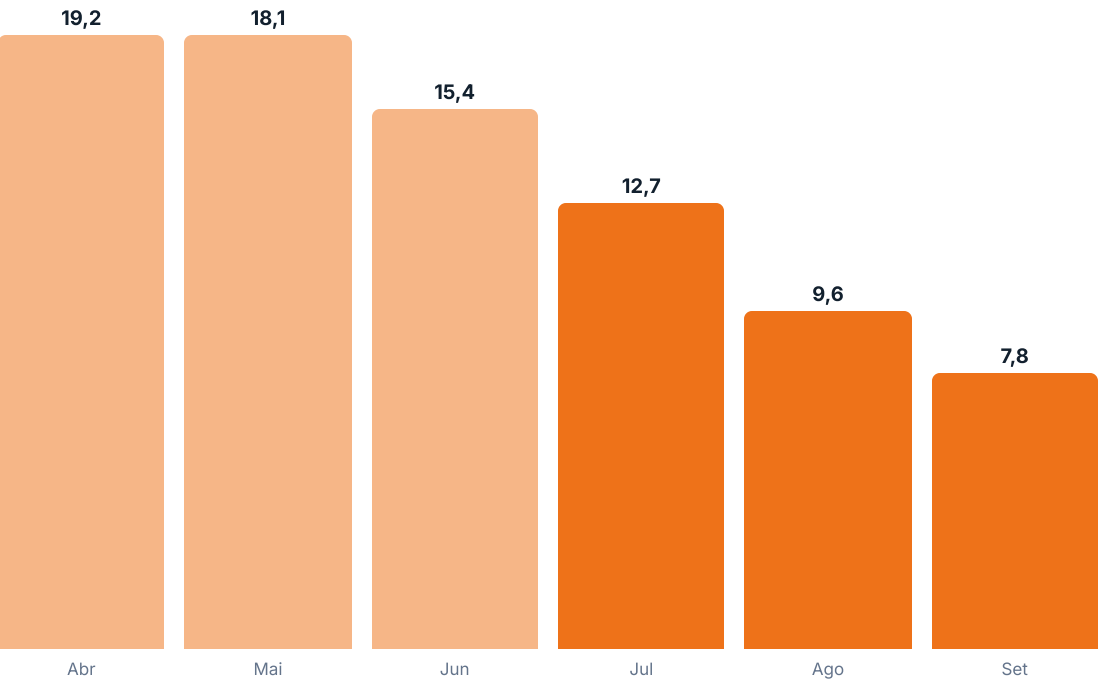
meta ≤ 10% · **abaixo**

FALTAS EM CONSULTA

7,8 %

era 19,2% antes da confirmação

Faltas em consulta agendada, por mês



A queda começa no mês em que a confirmação por WhatsApp entra.

A conta fica à vista

Cada indicador mostra a fórmula, o que entra e o que não entra. Quem recebe o número consegue conferir de onde ele veio.

Recortado como a gestão precisa

O mesmo indicador aberto por hospital, policlínica ou unidade básica, no mês, no trimestre ou no intervalo que se escolher.

SERVE PARA CONTRATO

Onde há contrato de gestão com meta, o indicador deixa de ser planilha entregue pelo prestador e passa a ser apurado na base da secretaria — por unidade e por período.

0 retrato de quem fala com o cidadão

MENSAGENS NO MÊS

18.4 mil

72% enviadas pelo sistema

ENTREGUES

96,2 %

falha quase toda por número inválido

1ª RESPOSTA HUMANA

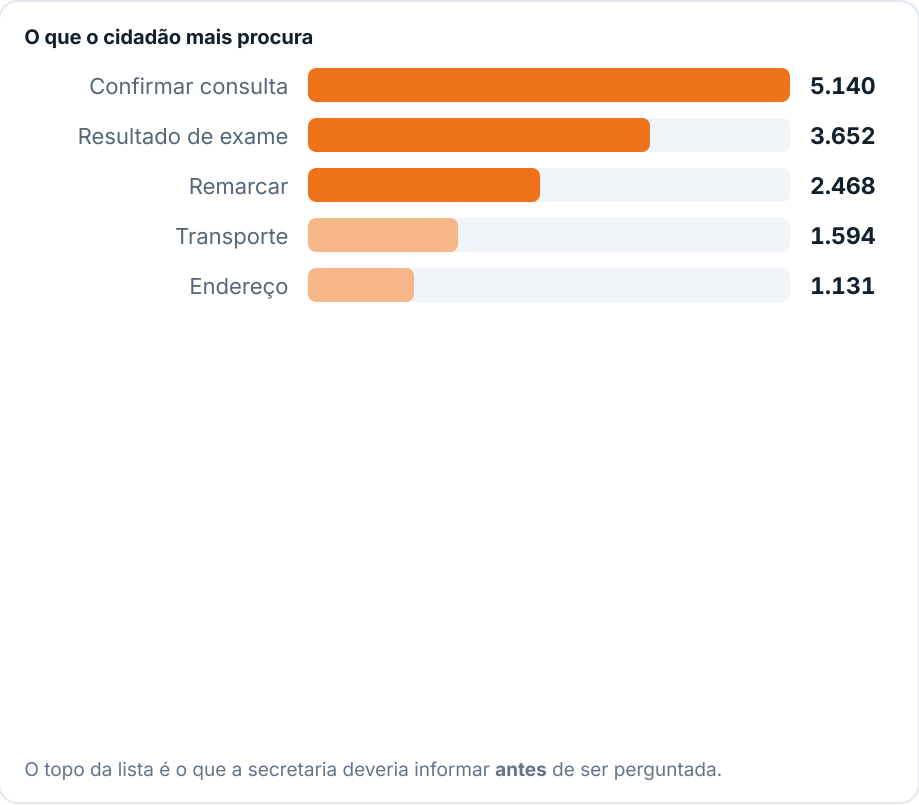
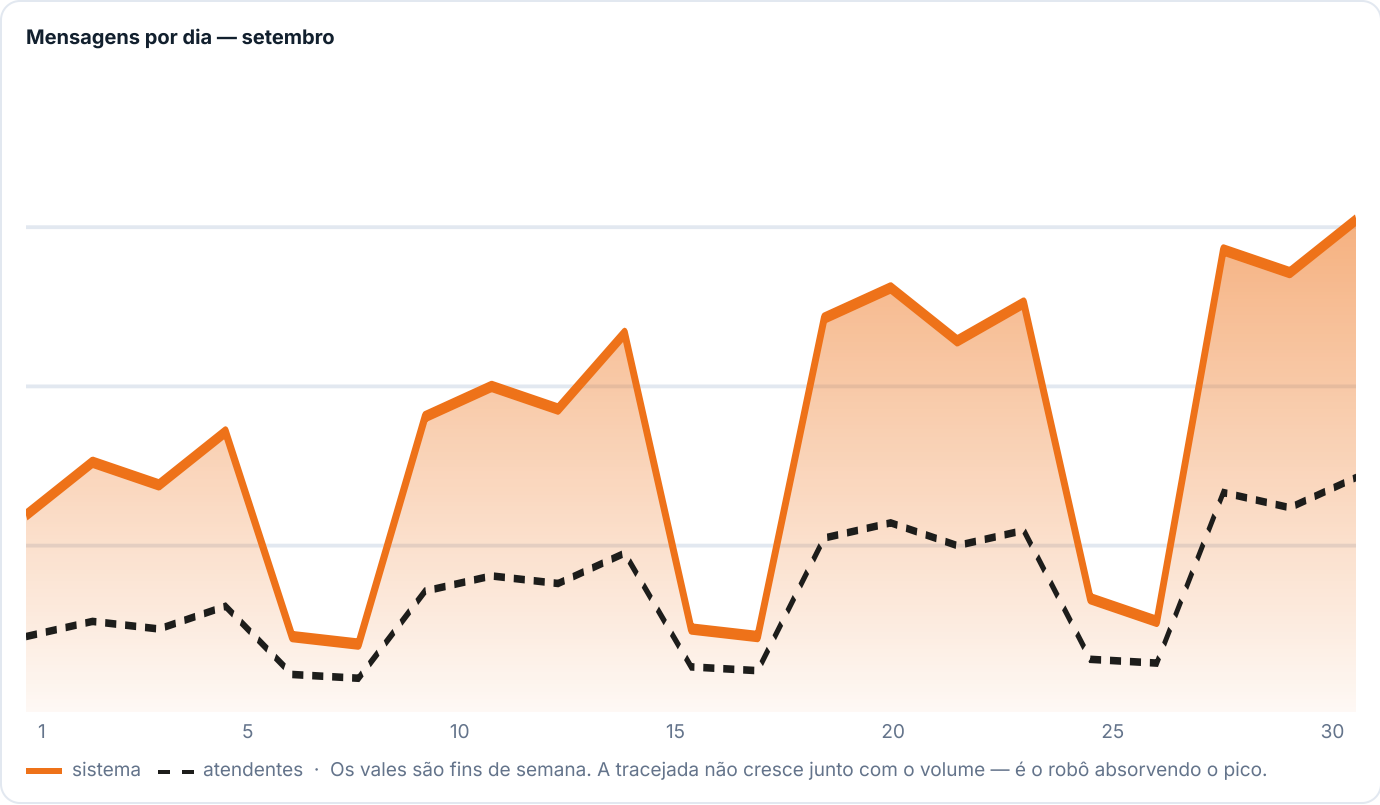
7 min

mediana, horário comercial

RESOLVIDAS PELO ROBÔ

61 %

sem passar por pessoa



Quem fez o quê, e o que fazer quando falha

Duas coisas que só aparecem depois de instalado — e é tarde para descobrir que não têm.

REGISTRO

Nada se apaga

Cada alteração fica gravada com autor, data e o que mudou. Correção é registro novo, não borracha. Quando alguém pergunta “quem cancelou isso?”, tem resposta.

FALHA

O erro avisa antes do usuário

Quando algo quebra, o sistema registra e avisa a equipe técnica na hora. O usuário recebe um código para informar — ninguém precisa descrever a tela de memória.

SUPORTE

Chamado dentro do sistema

Quem usa abre o pedido na própria tela, acompanha a resposta e sabe em que pé está. Não se perde em grupo de mensagem.

CADA UM VÊ O QUE É DELE

O acesso é montado por perfil: a recepção vê a recepção, a unidade vê a unidade, a regulação vê a rede. Dado de saúde é dado sensível, e o sistema trata assim por padrão — na dúvida, nega.

O MANUAL MORA DENTRO DO PRODUTO

Cada tela tem a sua explicação a um clique, com busca e passo a passo. O treinamento não depende de lembrar o que foi dito na implantação.

Quem fez o quê, e quando

● ● ● Trilha · solicitação 2026-018842 · Raimunda Nonata Freire · cardiologia

18/05 · 10H04 · POLICLÍNICA DO CENTRO

Aberta por Carla S. (unidade solicitante)

Com justificativa e ECG anexado.

20/05 · 15H31 · REGULAÇÃO

Assumida por Rita M. — prioridade Normal → Alta

Motivo registrado: hipertensão e idade.

02/07 · 09H12 · REGULAÇÃO

Devolvida à unidade por Paulo R. — pendência: exame prévio vencido

O relógio da espera fica suspenso enquanto a ponta resolve.

HOJE

Aguardando vaga há 128 dias

Cada linha acima tem autor, data e o papel de quem fez.



PARA QUE SERVE NA PRÁTICA

Para responder auditoria e órgão de controle — e, principalmente, para encerrar a discussão interna sobre “quem cancelou isso”, que é o uso mais frequente. Ver também é ato: revelar identidade de denunciante ou abrir a chave de um agendamento fica registrado.

Quando alguma coisa **não funciona**

**1****A tela falha**

Acontece em todo sistema. A diferença é o que vem nos dez minutos seguintes.

2**O sistema avisa primeiro**

A falha é registrada e a equipe técnica recebe o aviso — antes de o usuário reclamar.

3**O usuário recebe um código**

ERRO-4YCCKQ. Em vez de descrever a tela de memória, informa o código.

4**O chamado nasce na tela**

Abre ali mesmo, acompanha a resposta e sabe em que pé está.

5**Reincidência aparece**

Erro já resolvido que volta gera registro novo — é assim que se descobre correção que não pegou.

**POR QUE ESTÁ NESTE MATERIAL**

Nada disso aparece em demonstração. Só depois de instalado — quando é tarde para descobrir que não tem.

0 manual mora dentro do produto

● ● ● smsmais.saude.niteroi.rj.gov.br/app/manual/ confirmacoes

Confirmações ?

As quatro abas · Não confirmados, Confirmados, Contato errado, Pendentes

O que fazer quando o número não é do paciente

Simulação: assuma um caso e envie para pendente

Quem vê a aba Equipe · permissão própria

O "?" ao lado do título de cada tela leva ao artigo dela — não a um manual genérico de 200 páginas.

buscar: "número errado" · 3 resultados

artigo

seção

clicável

seção

"A menina nova aprendeu sozinha. Clicou no interrogação."



A REGRA

Toda alteração que alguém vê ou faz é confrontada com o manual na mesma entrega. Manual desatualizado mente com ar de autoridade — e treinamento que depende de lembrar a implantação não sobrevive à primeira troca de equipe.

PARTE 4

0 dado por baixo

Nada do que veio antes funciona se o mesmo cidadão for cinco pessoas diferentes. Esta parte é a fundação — e é a que menos aparece quando está bem feita.



Cinco registros, uma pessoa

● **Prontuário da UBS**

nome com abreviação

● **Prontuário do hospital**

data de nascimento digitada errada

● **Sistema de regulação**

só o CNS

● **Base nacional**

CPF e endereço antigo

● **Recepção, ontem**

telefone novo

UM CADASTRO SÓ

O documento manda

CPF e cartão do SUS identificam a pessoa. Cada dado carrega de onde veio. Telefone novo entra sem apagar o antigo. Quem não tem CPF entra marcado, para a recepção resolver depois — sem travar o atendimento de hoje.

O QUE ISSO DESTRAVA

Só existe histórico do paciente se houver um paciente só. Toda a leitura de “o que já foi feito por esta pessoa” depende deste ponto — é por isso que ele vem antes dos outros.

O histórico dos sistemas **que a rede já usa**

**1**

O prontuário continua

Quem atende não muda de tela. A plataforma só lê.

2

Lê do jeito de cada um

Cada produto guarda as coisas à sua maneira; o entendimento se escreve uma vez.

3

Reúne sob o mesmo cidadão

Atendimentos, exames e medicações de sistemas diferentes, na mesma linha do tempo.

4

Roda sozinho

Leitura contínua, acompanhada: o que entrou, o que faltou, o que voltou a tentar.

5

O legado também

Sistema aposentado ainda guarda muita história. É lido uma vez e incorporado.



O QUE NÃO MUDA

Nenhum prontuário sai de operação para a plataforma entrar. Ela lê o que ele registrou — não escreve nele e não altera a rotina de quem atende.

De cada 100 registros antigos, o que entra

91

entram limpos

6

divergência

3

rejeitados

Viram histórico do cidadão — com a origem de cada dado registrada.



Pessoa decide, com as duas versões à vista. O sistema não escolhe sozinho qual nome é o verdadeiro.



Ficam nomeados numa lista: documento inválido, data impossível, registro sem pessoa.

DIVERGÊNCIA**Quando as fontes discordam**

Dois sistemas com nomes ou datas diferentes para o mesmo CPF: vira pendência para alguém arbitrar — não silêncio, não sobrescrita.

A RESSALVA HONESTA**Nunca é instantâneo nem 100%**

O que se promete é que **o que não entrou fica visível e nomeado** — não que tudo entra perfeito. Base antiga tem dado ruim; fingir que não tem é o que estraga a base nova.

Nomes diferentes, **exame igual**

EM CADA SISTEMA

"US ABDOME TOTAL" no SISREG · **"Ultrassonografia de abdômen total"** no SERNIT · **"USG abd. total"** no prontuário.

Três nomes, três filas, três contagens que ninguém soma.



NO CATÁLOGO

Um procedimento só, com o nome que cada sistema usa pendurado nele.

O pareamento é sugerido pela máquina e **confirmado por pessoa**. A fila passa a ser somável.

UNIDADES

Vêm do cadastro nacional

Código, nome e endereço do registro oficial.
Unidade nova aparece sem digitação.

PROFISSIONAIS

Médicos e demais

Conselho, especialidade e onde atende — o que diz quem pode laudar e quem assina o quê.

PROCEDIMENTOS

A tabela oficial

O catálogo nacional, com o nome que cada sistema de regulação usa para o mesmo exame.

PARTE 5

Feito para a sua casa

Uma instância da FMS, com a marca de Niterói e as regras de Niterói. O que muda de município para município é cadastro, não programação.

A sua marca, **as suas regras**

O que muda de um município para outro é cadastro — não versão de sistema.

Uma instância da FMS

Servidor, banco e endereço próprios. Os dados de Niterói não dividem lugar com os de ninguém — e o que acontece em outro cliente não afeta esta casa.

A identidade é de vocês

Nome, logo, cores e contatos vêm do cadastro. O sistema se pinta com a marca de Niterói — inclusive no laudo em PDF e no app do cidadão.

As listas são suas

Unidades, especialidades, tipos de exame, modelos de laudo, assuntos e prazos: tudo editável por quem opera, sem chamar a gente.

Cada um enxerga o seu

O acesso é montado módulo a módulo e ação a ação. Um perfil para a recepção, outro para a regulação, outro para a direção.

MÓDULO É ESCOLHA, NÃO PACOTE

A secretaria liga o que vai usar. Quem só precisa de exames e laudos não leva transporte de pacientes na frente; quem começa pela ouvidoria não precisa da regulação no primeiro dia. O que estiver desligado não aparece no menu de ninguém.

E DEPOIS

Cresce por cadastro

Unidade nova, aparelho novo, módulo novo: entram pela configuração, com o sistema no ar.

Cada um enxerga o que é dele

Perfis x módulos — um recorte

PERFIL	REGULAÇÃO	EXAMES	LAUDO	ATENDIMENTO	OUVIDORIA	INDICADORES	AUDITORIA
Recepção da unidade	½	✓	—	✓	—	—	—
Regulador	✓	½	—	—	—	½	—
Médico radiologista	—	✓	✓	—	—	—	—
Ouvidor	—	—	—	—	✓	½	—
Coordenação	½	½	—	✓	½	✓	✓
Direção	½	½	—	½	½	✓	✓

✓ vê e faz ½ só consulta — não aparece no menu. Um recorte de 7 dos 75 módulos.

75 módulos x 4 ações

ver, incluir, alterar, arquivar — combinados em perfis prontos que se aplicam a quem chega, sem remontar permissão por pessoa.

POR UNIDADE

Quem é da unidade vê a unidade; quem é da regulação vê a rede. Na dúvida, o sistema **nega**.

ASSUNTOS SEPARADOS DE PROPÓSITO

Ver a produção das colegas, revelar identidade de denunciante, corrigir de quem é um exame e disparar mensagem ao cidadão são permissões próprias, desligadas por padrão. Não são graus do mesmo acesso — são pessoas diferentes.

A marca vem do cadastro, não do código

Sistema > Instituição

Nome	Fundação Municipal de Saúde de Niterói
Cor primária	 #EE7219
Logo	
Domínio	smsmais.saude.niteroi.rj.gov.br
WhatsApp oficial	+55 21
Encarregado de dados (LGPD)	lgpd@saude.niteroi.rj.gov.br

O que se salva aqui aparece no login, no PDF do laudo, na página pública de verificação e no app do cidadão.

INSTÂNCIA

Servidor e banco próprios

Os dados de Niterói não dividem lugar com os de ninguém. O que acontece em outro cliente não afeta esta casa.

POR ISSO

Trocar de município é cadastro

Este material inteiro está em laranja porque a cor veio deste campo. Nenhuma linha de código mudou.

Resultado de exame não vai para telefone duvidoso



Por onde **se começa**

Não é tudo de uma vez. Escolhe-se a frente que mais dói e ela entra primeiro.

1

A instância no ar

Servidor, endereço e a identidade de Niterói. A rede de unidades entra pelo cadastro nacional, sem digitação.

2

As integrações

Os sistemas que a casa já usa passam a conversar com a plataforma. É a etapa que depende de acesso, não de desenvolvimento.

3

Quem faz o quê

Perfis, responsáveis por área e prazos internos. É a decisão que mais pesa no resultado — e é da casa, não nossa.

4

Entrada em operação

Começa pela equipe, com treinamento e manual dentro do produto. O canal do cidadão abre depois, quando a rede já responde.

O QUE PRECISA SER DECIDIDO

- Por qual frente começar
- Quem responde por cada área e em quanto tempo
- Qual número de WhatsApp é o oficial da secretaria
- Quais sistemas entram na primeira rodada

UMA RESSALVA HONESTA

Isto ainda não é proposta

Este material mostra o que a plataforma faz. Prazo e preço só depois de sentar com a equipe da FMS e entender o volume, os sistemas e o fluxo de hoje — não há levantamento de campo em Niterói.

O que está pronto e o que está no roteiro

ENTREGUE — O QUE ESTE MATERIAL MOSTROU

- ✓ **Regulação e fila** — SERNIT, SISREG e SER lado a lado, com trilha
- ✓ **Agenda** — oferta x ocupação, alterações avisadas, simulação
- ✓ **Exames e laudos** — lista por aparelho, acervo único, laudo assinado no celular
- ✓ **Contato com o cidadão** — app, WhatsApp oficial, confirmação, robô
- ✓ **Transporte de pacientes, ouvidoria, indicadores**, consulta em português
- ✓ **Telefonia IP** das unidades, central e gestão de ramais

NO ROTEIRO — MARCADO COMO ROTEIRO

- **Ramal por login** e a chamada gravada e transcrita dentro do cadastro do paciente. A telefonia já opera; falta amarrar ao cadastro.
- **Resultado laboratorial**. A solicitação já é classificada e regulada como as demais; guardar e exibir o resultado é o passo seguinte.

Duas linhas. Curtas e verificáveis — e é por isso que estão escritas.

POR QUE DIZER ISTO EM VOZ ALTA

A régua deste material: o que roda aparece como entrega, o que falta aparece como roteiro — e nada aparece como os dois. Um material que só promete não deixa ninguém conferir nada depois.

Como este material foi montado



AS TELAS

São o sistema real

"Não houve levantamento de campo. O produto faz hoje, campo a campo. O que muda nelas é o cenário, não o comportamento. em Niterói. **O que está aqui é o produto**; o volume de vocês, eu ainda não conheço."

São cenário, não operação

Nomes de paciente, protocolos e números são fictícios e coerentes entre si — a mesma Terezinha atravessa a fila, o WhatsApp e a ligação. Nenhum dado real de paciente entrou aqui.

O QUE VEM DEPOIS

Uma conversa com a equipe para entender os sistemas de hoje e por qual frente faz sentido começar. Com isso, a proposta sai com número — e com o que dá para prometer.

EM UMA FRASE

Vocês já têm os sistemas. O que falta é o que **liga** tudo e entrega ao cidadão.

PRÓXIMO PASSO

Uma conversa com a equipe da FMS para entender os sistemas de hoje, o volume e por qual frente faz sentido começar. Com isso, a proposta sai com prazo e número.

DEMONSTRAÇÃO

A plataforma pode ser aberta ao vivo, com a marca de Niterói, numa instância de avaliação — do pedido ao laudo no celular.



SMSMais — plataforma de gestão da saúde municipal
Automais Comércio e Serviço de Automação Ltda

Bernardo Almeida

bernardo.almeida@automais.com · +55 21 97999-7000 · automais.com